Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent9vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5239155-73.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: ENY JORDAO DA SILVA

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

ENY JORDAO DA SILVA ajuizou *AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS* em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA,** partes já qualificadas. Narrou que é beneficiária de plano de saúde da ré, portadora de Doença de Alzheimer, com declínio cognitivo leve, e necessita fazer uso do medicamento **Lecanemab (Leqembi)**, 500mg/5ml, seis fracos ou 200mg/ml 10mg/kg a cada 15 dias de forma endovenosa, prescrito pelo seu médico assistente, pelo prazo de 12 a 15 meses.

Alegou que o medicamento teria a função de retardar significativamente a progressão da doença, prevenindo a evolução para demência irreversível, preservando sua autonomia e melhorando sua qualidade de vida. Afirmou que já utiliza há 20 anos medicamentos convencionais que apenas proporcionam alívio temporário, sem alterar o curso da doença, tornando imprescindível o início urgente do tratamento recomendado. Referiu que a ré negou a cobertura do medicamento, sob o argumento que este não estaria contemplado no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumentou que a negativa seria abusiva, pois o medicamento é essencial para sua saúde e estava devidamente prescrito por profissional habilitado.

Apontou que a negativa gerou aflição e sofrimento psicológico, diante do risco de agravamento irreversível da doença. Requereu a concessão de tutela de urgência para o fornecimento imediato do medicamento, conforme prescrição médica, ou, alternativamente, o bloqueio de valores para custeio dos três primeiros meses de tratamento, no total de R$ 48.600,00. No mérito, pleiteou pela condenação definitiva da ré ao fornecimento contínuo do medicamento, o reembolso de R$ 8.800,00, valor despendido com exames necessários ao acompanhamento de sua condição, que não foram autorizados pelo plano de saúde, e indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00. Pediu a gratuidade da justiça. Juntou documentos.

Deferida a tutela de urgência **(Evento 13)**

Custas quitadas em **Evento 16**.

Citada, a ré contestou **(Evento 31)**. Impugnou o valor da causa. Alegou que a negativa de cobertura era legítima devido à ausência de registro do Lecanemab na Anvisa. Afirmou que, conforme as disposições do art. 10, V, da Lei 9.656/98, que regulamenta a saúde suplementar havia exclusão da cobertura de medicamentos importados não nacionalizados. Invocou o Tema 990 do STJ, segundo o qual planos de saúde não são obrigados a custear medicamentos sem registro na Anvisa, conforme julgamento dos REsp n.º 1712163/SP e n.º 1726563/SP, que reconhecem como legítima a recusa do custeio de medicamentos não registrados. Detalhou o processo de registro de medicamentos na Anvisa, com avaliação técnica rigorosa em três fases. Citou enunciados do CNJ que desestimulam ordens judiciais para fornecimento de medicamentos não registrados ou experimentais, como o Enunciado n.º 6 e n.º 26. Refutou o pedido de danos morais, argumentando que a negativa de cobertura baseava-se em cláusulas contratuais e normas legais, não configurando ilícito. Requereu a improcedência da demanda.

Houve réplica **(Evento 36)**

Intimadas as partes a dizerem do interesse na produção de provas, nada requereram.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando os limites aos quais se restringiu a controvérsia, dispensável a produção de outros meios de prova, o que autoriza o imediato julgamento da lide, no estado em que se encontra o processo (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

O valor da causa em ações de fornecimento de tratamento médico é estipulado com base no **artigo 292 do Código de Processo Civil (CPC)**, que estabelece**,** que assim estabelece:

V - quando a obrigação for de prestação de alimentos ou de ***cumprimento de prestações vincendas****,* ***a soma de doze prestações mensais pedidas pelo autor, quando se tratar de obrigação por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano; sendo a prestação por tempo inferior, a soma das prestações;***

VII - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

Na hipótese dos autos, a autora estabeleceu o valor baseando-se nos orçamentos acostados, bem como ao valor pretendido a título de indenização extrapatrimonial e ressarcimento de exames já realizados, nada havendo a reparar quanto ao ponto.

Passo ao exame do mérito.

No caso em tela a parte autora postula pela obrigação da operadora de saúde em fornecer tratamento com o produto ***Lecanemabe*** para doença *de* Alzheimer CID F 06.7, prescrito pelo seu médico.

De início, observo que a relação entretida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, o que já se encontra sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

"*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)."

O contrato é regulado pela Lei 9.656/98, com diretrizes de Agência Reguladora. Aqueles que aderem ao contrato estão submetidos aos direitos e garantias da lei, mas também às suas limitações. Cabem as partes demonstrar se o caso está ou não dentro do escopo e objeto do contrato ou não.

Embora, em cognição sumária, tenha se entendido que a negativa se deu apenas pelo fato da ausência de previsão de cobertura para medicamentos para tratamento domiciliar não-oncológico, após a instrução a defesa da ré, verifica-se que trata-se de **fármaco importado não nacionalizado**, e não se enquadra, portanto, em quaisquer das exceções que justifiquem a obrigação de ser fornecido pela operadora do plano de saúde.

Ainda que incluída na lista de Denominação Comum Brasileiro o princípio ativo *Lecanemabe* , em consulta ao site da ANVISA, não verifica-se, até o momento, o registro do referido medicamento.

Ressalto que o Tema 990 do STJ dispõe que "*As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA*."

Destaca-se, ainda, o teor da nota técnica 5399/2023 NatJus/SP:

> *"O medicamento, sem aprovação na ANVISA,* ***tem previsão de custo nos EUA de USD 26.500,00 por paciente, o que equivaleria a algo em torno de R$ 130.000,00 por paciente.*** *Um medicamento a este custo com um efeito clínico apenas marginal ultrapassaria qualquer margem de custo-efetividade."*
>
> *(...)*
>
> *"Além disso, a droga possui apenas um ensaio clínico de fase 3 para corroborar sua eventual utilização. Dada a alta prevalência da condição, não se espera que apenas um ensaio clínico de fase 3 seja suficiente para determinar a eficácia de um novo tratamento. Ainda assim, pode-se observar que o único estudo realizado recrutou pacientes em uma fase muito inicial da doença, sendo mais da metade deles sem nem mesmo possuir diagnóstico de demência de Alzheimer. Mesmo assim, o resultado encontrado em 18 meses foi discreto.* ***Ainda que haja evidência estatística da diferença, uma variação tão pequena é praticamente irrelevante à prática clínica, ainda mais à luz de uma análise de custo-efeitvidade."***

Não obstante a possibilidade de concessão de *medicamento não* registrado na ANVISA quando (in) existente pedido de registro do *medicamento* no Brasil (salvo no caso de *medicamentos* órfãos para doenças rara e ultrararas); (ii) existente registro do *medicamento* em renomadas agências de regulação do exterior; e (iii) inexistente substituto terapêutico com registro no Brasil; deve-se atentar ao fato de que **as condicionantes mencionadas** são aplicáveis com relação à obrigação do Estado.

Quanto ao ponto, inclusive para prestação da obrigação pelo Estado, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte Tese (Tema 500/STF):

"1. O Estado ***não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais****.*

2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandemfornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União" (julgamento em 22/05/2019).

Ao analisar demanda semelhante (processo nº 5035372-76.2023.8.21.0027), trago a evidência a **Nota Técnica 184788**, de dezembro de 2023, que apresenta o seguinte teor:

(...)

"Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão Tecnologia:

MEDICAÇÃO - LECANEMAB Conclusão Justificada: ***Não favorável***

Conclusão: CONSIDERANDO que a paciente tem doença crônica, progressiva e incurável, descrita como doença de Alzheimer; CONSIDERANDO que o tratamento recomendado atualmente para a doença envolve o uso de drogas específicas (anticolinesterásicos, memantina); CONSIDERANDO que existe droga nova em estudo para o tratamento com resultados de eficácia modestos, chamada de lecanemab; CONSIDERANDO que os especialistas sobre o tema ainda não recomendam em consenso o uso desta droga; ***CONSIDERANDO que o medicamento não se encontra disponível no Brasil, não foi aprovada pela agência regulatória brasileira e não é coberto pelo sistema único de saúde; CONCLUI-SE que NÃO HÁ EVIDÊNCIAS para a prescrição e utilização do medicamento citado neste caso.***

Há evidências científicas? Não se aplica"

Assim, ainda que incidam, na espécie, as normas de proteção do código de defesa do consumidor, bem assim que o *medicamento* em questão tenha sido prescrito pelo *médico* que acompanha o quadro clínico da autora, *não* se pode esquecer que a relação havida entre as partes é **contratual**, e **a jurisprudência já consolidou entendimento** de que, em caso de inexistência de registro de *medicamento* na ANVISA, ou, então, autorização dela, descabe qualquer imposição de cobertura.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DE ALZHEIMER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ***LECANEMAB (LEQEMBI). NEGATIVA DE COBERTURA. FÁRMACO DE USO DOMICILIAR NÃO INCLUSO NO ROL DA ANS E SEM REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS A ENSEJAR O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE.*** *AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO, EM MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 53733054320238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovana Farenzena, Julgado em: 13-06-2024)*

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA.
1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As ***operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.***
2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
2.2. É ***legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA****, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A* ***determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.***
2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário.
3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1726563 / SP)

"[...] é possível concluir pela ***licitude da exclusão, pelas operadoras de planos de assistência à saúde - Saúde Suplementar -, de tratamento médico envolvendo medicamento importado, sem registro pela ANVISA, até mesmo porque as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplicam apenas subsidiariamente aos contratos entre usuários e suas operadoras, conforme dicção do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998, razão pela qual, nas hipóteses de aparente conflito de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, devem prevalecer as normas de controle sanitário, que visam ao bem comum".****(REsp 1712163 / SP)*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ALZHEIMER. MEDICAMENTO LEQEMBI (LECANEMAB). AUSENTE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 990/STJ. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE. MANTIDO O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1) Caso dos autos em que inaplicável a Lei dos Planos de Saúde, uma vez que o contrato havido entre as partes foi firmado em 1994, não sendo adaptado. 2) De qualquer forma, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos Recursos Especiais 1712163/SP e 1726563/SP - Tema 990 -, firmou a tese no sentido de que "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". 3) No que respeita ao fármaco em questão, LEQEMBI (LECANEMAB), inexiste registro aprovado pela ANVISA. 4) Relativamente à alegação de que o fármaco foi incluído na Denominação Comum Brasileira (DCB), a qual se refere à denominação do fármaco ou princípio ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária (Lei 9.787/1999), importa ressaltar que tal inclusão não se confunde com o efetivo registro do medicamento, como bem apontou a decisão recorrida. ***O registro na ANVISA refere-se à aprovação da finalidade para uso do fármaco, o que não equivale ao registro da sua nomenclatura/denominação.5) Ainda que incidam, na espécie, as normas de proteção do código de defesa do consumidor, bem assim que o medicamento em questão tenha sido prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico da autora, não se pode esquecer que a relação havida entre as partes é contratual, regida por lei e a jurisprudência já consolidou entendimento de que, em caso de inexistência de registro de medicamento na ANVISA, ou, então, autorização dela, descabe qualquer imposição de cobertura,*** *o que afasta, a priori, a probabilidade do direito da parte, requisito necessário à concessão da tutela pretendida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 53849930220238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 29-02-2024)*

Segundo o site da Academia Médica (https://academiamedica.org/), o uso do medicamento ainda é objeto de diversas controvérsias, sendo que os estudos relativos à eficácia do tratamento são considerados preliminares e incipientes:

Eficácia e Segurança: Uma Análise Cautelosa

O ponto central do debate é se a redução do declínio cognitivo proporcionada pelo Lecanemab é clinicamente significativa para justificar seu uso, dadas as preocupações com os efeitos colaterais. Em um ensaio clínico de fase III publicado em 2022, o medicamento demonstrou reduzir o declínio cognitivo em 27% após 18 meses de tratamento em comparação com um placebo. No entanto, alguns especialistas argumentam que os efeitos são modestos e as diferenças absolutas na função cognitiva são pequenas.

Além disso, preocupações com a **segurança do tratamento** têm sido destacadas, especialmente em relação às anormalidades relacionadas ao amiloide por imagem (ARIA), que podem incluir sangramento ou inchaço no cérebro. Essas complicações são raras, mas significativas, e foram motivo de alerta por parte da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA).

Nesse passo, *in suma*, a negativa de cobertura do medicamento **Lecanemab (Leqembi)** encontrou respaldo legal e contratual, visto que, conforme o disposto no artigo 10, inciso V, da Lei nº 9.656/98, não há obrigação das operadoras de planos de saúde de fornecerem medicamentos importados que não possuam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com jurisprudência consolidada no **Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)**, que reafirma a inexistência de obrigação de cobertura de medicamentos não registrados.

A conduta da ré, portanto, não configurou abuso de direito ou descumprimento contratual ilícito, mas sim o estrito cumprimento de uma obrigação legalmente delimitada. A negativa, por si só, ainda que gere desconforto à autora, não possui gravidade suficiente para caracterizar uma violação dos direitos de personalidade, como a dignidade, a honra ou a vida privada, elementos necessários para a configuração de dano moral.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o mero descumprimento contratual, sem demonstração de situações excepcionais, caracteriza-se como mero dissabor, insuficiente para gerar indenização por danos morais. A inexistência de ilicitude na negativa de cobertura exclui, por consequência, qualquer fundamento para o pleito de indenização.

Dessa forma, considerando que a conduta da ré foi lícita, amparada por previsão legal e jurisprudencial, e que não houve demonstração de violação grave aos direitos de personalidade da autora, afasto a condenação ao pagamento de danos morais pretendida.

Por fim, com base na análise detalhada da inicial, não há informações claras ou documentos nos autos que expliquem detalhadamente a natureza ou finalidade dos exames cujo ressarcimento é solicitado.

A autora não apresentou qualquer justificativa médica específica ou vinculação direta desses exames ao tratamento requerido com o medicamento **Lecanemab (Leqembi)**.

Além disso, não consta nos autos prescrição médica ou qualquer recomendação explícita por parte do médico assistente solicitando a realização desses exames, tampouco pedido administrativo e cobertura negada pelo plano de saúde, motivo que improcede o pedido.

ISSO POSTO, revogo a tutela deferida, e JULGO **IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por **ENY JORDAO DA SILVA,** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.**

A requerente arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que fixo em R$ 1.500,00, forte no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIA MARIA PIRES TEDESCO, Juíza de Direito**, em 08/12/2024, às 22:38:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10072953648v23** e o código CRC **b90960dc**.